על שחיינים, צוללנים ומה שביניהם: התבוננות אינטגרטיבית על...

hebpsy.net /articles.asp

ד"ר הילי כוכבי



כללי

תקציר

מחברים

ציטוט

מאמרים | 20/3/2018 | 9,842

מקצוע הפסיכולוגיה החינוכית עוברים מחזור תהליכי שינוי מואצים, המלווים בין בבחינת הזהות המקצועית העוסקים בו. מאמר זה מבקש לבחון מספר היבטים מרכזיים של... המשך

פסיכולוגיה חינוכית

על שחיינים, צוללנים ומה שביניהם

התבוננות על יופיו ועל מורכבותו של מקצוע הפסיכולוגיה החינוכית

מאת הילי כוכבי

המאמר מבוסס על הרצאה שהועברה בסמינר קדם-ההרצאות השנתי של הפסיכולוגים, דצמבר 2017. החיסונים הפרטיים המתוארים במאמר השמירה על חיסיון המטופלים; ההתייחסות לדיון הפייסבוק מובאת באישור מנהלת הקבוצה, והציטוטים מתוכו שונו מעט תוך שמירה על רוח הדברים.

> הכול –
>
> מילה מתנשאת, נפוחה מיוהרה,
>
> מן הראוי שתיכתב במרכאות כפולות.
>
> מעמידה פנים שאין היא מחסירה דבר.
>
> היא מכנסת, מקיפה, מכילה, אוצרת בתוכה.
>
> בעוד שאין היא אלא
>
> רסיס מן הסערה.
>
> (ויסלבה שימבורסקה)

ערב אביב 2017 התחולל דיון סוער בקבוצת הפייסבוק של הפסיכולוגים החינוכיים. פוסט שנפתח בשיר "הכול" של המשוררת הפולניה שימבורסקה מעוררת בעקבותיו דיון רב יצרנים, שופע עמדות, דעות ומחשבות באשר למהות הגדרת תפקיד הפסיכולוג החינוכי. ואלה היו מקצת מהקולות שעלו באותו דיון:

> - "אנחנו יודעים מעט מדי על יותר מדי..."
>
> - "זה יוצר אצלי תסכול..."
>
> - "הדרישות הולכות ותרבות..."
>
> - "אנחנו מתפשרים... לוקחים על עצמנו אחריות-יתר... צריך להפסיק עם זה"
>
> - "זוהי יומרה ללא כיסוי..."
>
> - "לא ניתן להגיע להעמקה אמיתית בכל אחד ואחד מהתחומים..."
>
> - "היבריס"... "גרנדיוזיות"
>
> - "תפסת מרובה לא תפסת..."

ומנגד, היו גם קולות רבים אחרים:

- "שיר מקסים... ואכן... הכול. הכול אנחנו צריכים ולהכיל..."

- "ריבוי התחומים הוא הייחוד וליבת העבודה של הפסיכולוג החינוכי"

- "ואולי זה מה שמייחד את מי שעוסק בילדים?

- "השפעה ההדדית של מגוון התחומים מעשירה מאוד את המקצוע הייחודי שלנו."

- "אנחנו מתמחים בנפש האדם. מתוך נקודת המוצא הייחודית הזו אנחנו יכולים לעזור למערכת במגוון דרכים... אין כאן פיזור לשלוש התמחויות שונות, אלא ביטוי של דבר אחד."

הדיון הלך והסתעף, התפרש על פני עמודים רבים. נכתבו בו דעות רבות, עמדות שונות ומגוונות.

קראתי את השרשור האינסופי בנשימה עצורה, נעה בין עמדה מקצועית אחת לאחרת. כשסימתי לקרוא אותו חשתי התרומות רוח. לתחושתי, הדיון הסוער בפייסבוק לא יכול היה להתנהל לפני עשר שנים. הדיון הסוער בפייסבוק מוכיח פסיכולוגיה החינוכית הנוכחית במקום אחר. הם מוכיחים שפסיכולוגים חינוכיים מזהים החזקות לתפקידם, הם חשים גאווה במקצוע, ומוכנים לבחון את הנקודות הזקוקות, כמו גם את נקודות התורפה, של המקצוע המור והיפה. זו תהיה גם מטרתי במאמר הנוכחי.

בחרתי בשבעה מאפיינים מרכזיים של המקצוע, כפי שאני תופסת אותו, שאותם אבקש לבחון ולהציג: ראייה רחבה ואינטגרטיבית; עבודה מערכתית; רוחב היריעה ומגוון תחומי העיסוק; קידום בריאות נפשית; גמישות; יצירתיות ומרחב להתפתחות אישית; ולבסוף – יוקרה וגאווה במקצוע. ההפרדה בין המאפיינים היא שרירותית למדי, וללא ספק שיש חפיפה; יתרה כתוצאה – ככל הנראה ניתן יהיה לאתר ולהתייחס למאפיינים נוספים. ובכל זאת, נדמה לי שהתבוננות במאפיינים המוצגים להלן עשויה לעזור לשרטוט תמונה שלמה, רחבה ואינטרפרטציה של מקצוע הפסיכולוגיה החינוכית.

1. רא רחבה ואינטגרטיבית – בעלות "לנצח על התזמורת"

אחד ממאפייני הבולטים של העבודה הפסיכולוגית-חינוכית קשור ליכולתו של הפסיכולוג החינוכי להתבונן בכל אירוע הבא לפתחו מתוך זווית התבוננות רחבה ואינטגרטיבית. אדגים זאת דרך סיפורו של יונתן (שם בדוי).

יונתן היה ילד בן 11 שהמציאות טפחה על פניו. הוא היה בן יחיד להוריו, אמו נטשה אותו כשהיה בן שלוש, והוא סבל מחרדת פרידה מאביו – איש דל רגשית, שנהג להיעלם לו בכל הזדמנות. יונתן הגיעה למרפאה ציבורית אוקיבל טיפול פסיכולוגי באוריינטציה דינאמית. הדרכים התנהל בתוך חדר הדרכים והפעולה בעולמו הרגשי של יונתן – בכאב הרב שהיה אצור בו ובחוסר היציבות שחש בחייו. יונתן הגיע בקביעות טיפול. דרך משחק בחדר עוים, הוא חשף את למו הפנימי ושיתף ברגשותיו. האב הוזמן לפגישות של הדרכת הורים אחת לחודש, אך נהג להחסיר את רובן. כעבור כשנה הסתיים טיפול. הפסיכולוגית המטפלת שהטיפול ביונתן התקדם והצליח.

ששנתיים מאוחרות יותר הגיעה אלא לידי אותה פסיכולוגית ה"תיק" של יונתן. הפעם הייתה זו כשעבדה כפסיכולוגית חינוכית בשירות הפסיכולוגי-חינוכי, ושימשה כנציגה בוועדה שדנה בענייני של יונתן. היא פותחת את התיק בהתרגשות. מעיון קצר בתיקדר הפיתוח שיונתן – הילד העדין והמתוק שהכירה – הצטרף לכנופיית

נערים והידר יציאה. לתדהמתה, גילתה הפסיכולוגית שיונתן למד בכל שנותיו בבית הספר היסודי בכיתה רגשית.

שאלות רבות התעוררו בה: "איך לא ידעתי שהוא בחינוך מיוחד? למה אני לא יצרתי קשר עם מחנכת הכיתה שלו? איך אני לא בדקתי את המקורות של התמיכה הטבעית בקהילה שבה הוא חי? איך זה לא איתרתי דמויות משמעותיות שבהן? הוא יכול להיעזר אילו מסגרות אחר-הצהריים יכול היה להשפיע עליו לטובה, להוציא? – ולו במעט – הדלות הרגשית שבה הוא חי...? ואיך לא פגשתי מדי פעם אותו ואת אביו ביחד?

שאלות אלה נשאלו בדיעבד. הן נשאלו מתוך צורת חשיבה המאפיינת את הפסיכולוגיה החינוכית. הן נשאלו מתוך זווית ראייה רחבה ואינטגרטיבית, הנותנת מקום רב למציאות חייו החיצונית של הילד, המתקיימת בצד זו הפנימית, עוטפת, וחשובה לא פחות ממנה.

"יותר פחות ופחות"

אני רואה את המטופל באופן רחב ואינטיגרטיבי הוא אחד הנושאים החשובים ביותר בעולם הרפואה, וכך גם הפסיכולוגיה, המסונף לעולם הרפואה. עולמנו מלא במומחים במגוון היודעים יותר טוב ופחות. ואולם, ראייה צרה והתמקצעות יתר מהוות מכשלה: טעויות דרמטיות וגורליות מתרחשות תדיר, עקב ראייה צרה מדי של המטופל, כאשר חסרה בונה את התמונה הרחבה (גרופמן, 2009). רופאים בעלי רמות מומחיות גבוהות רופאים בסימומים נקודתיים, לקחת בחשבון את ההקשר: את הרקע הגנטי של האדם, אורח החיים שלו, מצבו הנפשי, תרופות נוספות שיכולות לסבול מהן, תרופות שונות שהוא נוטל, וכדומה. כך תיאר את הבעיה פרופ' יוסף קלאוזנר, בתפקידו כיו"ר המועצה הלאומית לכירורגיה ומנהל האגף הכירורגי במרכז רפואי איכילוב:

> " רופאים מפתחים ידע ומיומנות יוצאים מהכלל, אבל בתחומים צרים. זה נהדר, אבל גם מסוכן. יש המון מומחים, חסרים רופאים שאפשר להגדירם "מומחי-על", כאלה בעלי מבט כולל שלא מקרוב בתחום ובאיבר מסוים, אלא בכל החולה. טיפול רפואי, תוך ויסות בין כל המומחים, שמאפשרת לראות את החקלאות בכללותו, היא יחידת רופא כיום. ". (בחור-ניר, 2007)

אנשים של פסיכולוגים חינוכיים להתבונן בכל אירוע שבו הם מעורבים מתוך זווית ראייה רחבה, הבנה עמוקה של משמעויות שונות, משיכה בחוטים רבים בו-זמנית וראיית תמונה מזווית מבט שונות – היא ללא ספק נכס משמעותי של הפסיכולוגיה החינוכית. בהמשך ישיר לכך, הפסיכולוגים החינוכיים אוחזים במיומנות חשובה ובכישרון "לנצח על התזמורת" – כלומר לשמש כ"מנהלי המקרה" (מנהלי תיקים), ובתוך כך לווסת ולתאם בין אנשי המקצוע, ובינם למען ההורים, המורים וכל מי שעשוי לסייע לקידום רווחתו הנפשית של הילד. מדובר בתפקיד חשוב ויקר ערך מאין כמותו.

2. עבודה מערכתית – "לא חייבים לכנס עשרה אנשים בחדר"

עבודה מערכתית היא אחד התחומים המעוררים אי-נוחות בקרב חינוכיים, בעיקר בראשית דרכם. עבודה מערכתית נתפסת כעניין מורכבת, הדורש היערכות לוגיסטית רבה ומיומנויות אישיות ומקצועיות שהפסיכולוגית לחשוש אינה מצויה בידו. ואולם, בשונה מתדמיתה, מערכתית היא מעל לכול צורת חשיבה שפסיכולוגית חינוכיים מורגלים לה ואמונים עליה. זוהי אמנם צורת חשיבה המתפתחת לאט ובהדרגה, אך בשונה מכפי שנוטים לחשוב, על מנת ליישם אותה אין הכרח לכנס עשרה אנשים בחדר; היא אינה מחייבת לוגיסטיקה

מורכבת, או תיאום של מפגשים עם אנשי מקצוע רבים. למעשה, כל שיחה של פסיכולוג חינוכי עם מנהל בית ספר על מהות עבודתו היא עבודה מערכתית. בכל כזה טמון פוט אל רב לתרומה לרווחתם הנפשית של שמונצי החשבון שיחה מערכת, כפי דגם במקרה הבא.

מנהלת תיכון אזורי גדול באחד שובי הפריפריה הגיעה לתפקיד עם רצון עז "להיות שם" עבור לקוח: להציל אותם מהחברה שמאיימת להשאיר אותם כל חייהם בשוליה, להציל אותם מעצמם. משאבים רבים השקיעה המנהלת ביצירת קשר אישי עם כל תלמיד ותלמיד. מאות רבות של תלמידים למדו בבית הספר – את כולם השתדלה המנהלת להכיר בשמותיהם, לכל אחד ואחת מהם היא ניסתה להתייחס באופן אישי, המותאם לצרכיו. הפסיכולוג החינוכי שעבד בתיכון התפעל מכוונותיה הטובות של המנהלת ומהמוטיבציה הרבה שהיא הביאה איתה לתפקיד.

ואולם, תוך כדי שנת העבודה, הבחין הפסיכולוג שחדר המורים נוטה להיות דליל ומוזנח. המורים בוחרים לצמצם את מי שהם בו. מורה מסוימת, שישב שבעה על מות אחיו, ביקשה להסתיר עובדה זו מחבריו לעבודה. מורה אחרת, שהשיאה את בתה, בחרה שלא להביא עוגה לחדר המורים, 'שלא ידע... זה מיותר...'. הפסיכולוג החינוכי שיקף מצב זה למנהלת. ביחד הם הבינו שמצי ה"ה" של המנהלת פגשו לתלמידים הביאו להזנח מקום של המורים – המשאב האנושי הכי חשוב עבור מערכת המורכבת הזו. המנהלת תצליח לראות את המורים, להתבונן בהם בעיניים טובות ומתפעלות, להיות מכוונות לצרכים שלהם, לגרום להם להרגיש שייכים ומחויבים לארגון, להנחות לגבי הערכים החשובים לה – הם יכולים לראות את התלמידים, לעזור להם, להתפעל מהם, ולהביא אותם להישגים אישיים וחברתיים. , כפי שהמנהלת שאפה שיקרה.

אותם שיחות שקיים הפסיכולוג החינוכי עם מנהלת התיכון – שיחות בגובה העיניים, באווירה תומכת, מתוך סקרנות משותפת וכוונותטיב את הרווחתם הנפשית של שיחות עיניים – הן דוגמאות לעבודה מערכתית חשובה ביותר. עבודה מערכתית הנעשית בשקט, בלי לוגיסטיקה מסובכת, ומבלי לכנס עשרה אנשים בחדר.

"אין ילד ללא מערכת"

חשיבה מערכת רלוונטית לא רק לעבודה במסגרות חינוכיות, אלא גם לעולם. להערכתי, אחת הסיבות הבסיסיות לרתיעה של פסיכולוגים חינוכיים מעבודה מערכתית קשורה לעובדה שכולנו "גדלנו", כך או אחרת, על מודל הפסיכולוגיה הקלינית.

כל אדם שעבר טיפול פסיכולוגי מוצלח חייו הבוגרים יכול להעיד על ערכן המופלא של ההכלה ההתכוונות המלאה של המטפל כלפיו. בטיפול ארוך טווח באדם הבוגר, נוצרת על פי רוב אצל המטופל חוויה שהמטפל נמצא שם כל בשבילו, עבורו ו"בעדו". ממש כפי שעושה זאת "האם הטובה דיה" עונה לתינוקה הרך (ויניקוט, 1960). אלא שבאופן פרדוקסלי, בשונה מטיפול במבוגרים, הרי שדוקא כאשר אנו עוסקים בילדים – אפשרות להכלה ולהתכוונות מלאה פשוט אינה קיימת. היא אינה קיימת משום שילד שייך בראש ובראשונה להוריו; הוא שייך למשפחתו, הוא שייך לבית הספר שבו הוא לומד, ולקהילה שבה הוא חי. כשרווחתם הנפשית של ילדים היא שעומדת לנגד עינינו, להכיר בעובדה שהמערכות השונות הן חלק בלתי נפרד מחיים. ממש כפי ש"אין תינוק ללא אם", כדברי ויניקוט, כך "אין ילד ללא מערכת". פסיכולוג שאינו "מחזיק בראש" את זה כולה תוך כדי מטפל בילד – חוטא לטובת הילד. טיפול פסיכולוגי בילד, אישיות פרטיות עמוקה למערכות השונות העוטפות אתו, ובראשן – ההורים, לא יועיל לקידום רווחתו הנפשית של הילד, ובסבירות גבוהה – אף עלולה להזיק (כהן, 2017).

יתרה מזאת, מניסיוני, רבים טובת הילד תושג ללא כל מעורבות ישירה איתו. רוב קרים, עבודה פסיכולוגית עם מערכת הילד לומד – עם מחנכת הכיתה, עם היועצת החינוכית, עם מנהלת בית הספר – שילוב עבודה טיפולית עם הורי הילד, לקדם לקדם את הרווחה הנפשית של הילד יותר מכל טיפול ישיר בילד עצמו. זוהי למעשה אחת הסיבות המרכזיות שפסיכולוגיות חינוכיים הם המופקדים על עבודה מערכתית בבית הספר – הם, ולא מומחים חיצוניים לייעוץ ארגוני. חשוב שלא להתבל – בעוד שהיה עץ הארגונים אחראי על "בריאות הארגון", הרי שהפסיכולוג החינוכי אמון על בריאותם הנפשית של הילדים הלימוד בארגון, ויש בידי הפסיכולוגים החינוכיים את הכלים לעשות זאת.

חשיבה מערכתית – גם בטיפול "פרטני"

תפיסת עולם מערכתית והבנה מערכתית נחוצות לכל מי שעובד עם ילדים – בין אם הוא פסיכולוג חינוכי, קליני או התפתחותי. אולם מסתבר שבפועל לא כולם העולם בה. על מנת לבחון זאת, ניקח כדוגמא את עולם עולם במתבגרים. האם אפשר לבקש במתבגרים ולקדם את רווחתם הנפשית על פי מודל מודל הנפשי במבוגר, וללא קשר ישיר ושוטף עם הוריהם? לתפיסתי, התשובה היא חד-משמעית – לא לעשות זאת. כך עולה למשל מהדוגמה הבאה:

שיר (שם בדוי), נערה מתבגרת בת 16, אינטליגנטית בולטת, עסוקה בשאלות לגבי הדימוי העצמי והחברתי שלה, ונמצאת במאבקים מתמשכים עם הוריה סביב נושא יומיומיות שונות. שיר מחליטה שהיא רוצה לפנות לטיפול פסיכולוגי. היא מקבלת המלצה מחברה לגבי פסיכולוגית יחידה, היא מתקשרת, מתאמת פגישה, ומודיעה להוריה כי היא לוקחת אותה אחת לשבוע לאותה פסיכולוגית, לשלם כמובן על דרכימיות, ו... לא לשאול שאלות רות. סודיות ופרטיות הן הרי "מעל לכול".

ההורים, מלאי רצון וכו' טובותטיב עם ב (ומצוידים במודל הקדם הליכי באדם), מצייתים להוראותיה של שיר. לא נוצר קשר בינם הפסיכולוגית. הם בקושי יודעים את השמה. הפסיכולוגית מצדה שומרת על "סודיות מקצועית", וההורים – מסיעים, משלמים, ושותקים. מכבדים את פרטיות בתם המתבגרת, ולא שואלים דבר. ככל שהטיפול מתקדם, הוריה של שיר מבחינים כי היא כועסת יותר, מתריסה, מסתגרת שעות רבות בחדרה. אין להם אפשרות להיכנס למרחבי דרכים. הקונפליקט בין שיר הוריה הולך ומעמיק.

הוריה של שיר לא יודעת שקיימת אלטרנטיבה. הם יכולים להיות חלק בלתי נפרד מהתהליך טיפולי בשיר. בגישה הייתה טיפולית שונה, פסיכולוגית פוגישה את ההורים אחת למספר שבועות, מטפלת בפרטני בשיר. מפעם לפעם אפשר היה לקיים גם פגישות משותפות, על פי הצורך. בגישה טיפולית שונה, *במרחב* המשותף. וכל זאת, לבטל את החשיבות הפרטיות והשמירה על סודיות. אכן מורכב. מורכב מאוד, אך אפשרי וחיוני.

התפיסה המערכתית – הטבה היטב בראיית העולם של הפסיכולוגים החינוכיים – מסייעת להם ומאפשרת להם לעשות זאת: לבנות את המורכבות, גם כשמדובר בטיפול "פרטני".

3. טווח רחב של תחומי העיסוק – "לא תפסת" (?)

חינוך מיוחד... פגיעות מיניות... לקויות למידה... ADHD... אובדנות... ASD... מחוננים... אירועי חירום... "חדשות משפחות"... רב-תרבותיות... מיומנויות חברתיות... נוער להט"בי... קהילתית... עבודה מניעתית... היבטים התפתחותיים בגיל הרך... הבנת פסיכו-דינאמית של מערכות... ועוד... ועוד...

וגם – אבחון פסיכולוגי... אבחון פסיכו-דידקטי... טיפול דינמי בילדים ובבני נוער... טיפולי CBT... טיפולי עבודה עם הורים... ועדות שילוב... ועדות השמה... אבחון מערכת... ייעוץ למערכת... התערבות מערכות... ועוד... ועוד...

אחת, אחת הסוגיות המטרידות יותר מכול את הפסיכולוגים החינוכיים היא סוגיית הצורך לחלוש מבחינה מקצועית על "הכול". פסיכולוגים צריכים לעסוק חינוכיים ומעמיקים בתחומים רבים ושונים מאוד זה מזה. הם יכולים להפעיל ולפעול באמצעות דרכי התערבות רבות מאוד ומגוונות.

ריבוי תחומי התוכן וערוצי פעולה מתבטא לא רק במציאות החיים בשטח, אלא גם בדרישות הפורמליות המוצבות בפני מיבקש לסיים התמחות בפסיכולוגיה חינוכית. אין ספק במקצוע עם רמת דרישות גבוהה ותובענית במיוחד. מצב זה מעורר אצל הפסיכולוגים החינוכיים חשש חשש מפני המה של "תפסת מרובה – לא תפסת".

המציאות מכילה "הכול"

פסיכולוגים חינוכיים עובדים ל"הכול", זה מהסיבה הפשוטה שהם עובדים בשטח, קרוב מאוד למציאות חייהם של הילדים שעל רווחתם הנפשית הם אמונים. פסיכולוג חי באירוע בבית הספר באירוע של פגיעה מינית – אין לו את הפריבילגיה לומר כי אין זה מתחום עיסוקו; כאשר פסיכולוגית חינוכית שומעת מגננת על ילד המגלה סימנים של עיכוב התפתחותי – לא תוכל לדחות זאת מעליה ולומר כי לא הוכשרה לכך. למעשה, המציאות עצמה היא שמכילה "הכול", ובכל יום היא בוראת אירועים ומצבים חדשים, אירועים ומצבים שטרם נחשפנו אליהם. מה שהפסיכולוגים החינוכיים עובדים ב"מגרש המשחקים" של המציאות, הם חייבים שיהיו בידיהם הכלים להתמודד עם אותו "הכול" – רחב, מגוון ולא תמיד צפוי.

רחב אינו שטחי

אם "רוחב יריעה" משמע שטחיות, הרי שלפסיכולוגים החינוכיים אכן יש סיבה טובה להיות מוטרדים. ואולם, לתפיסתי, יש כאן מידע רב "כשל מחשבתי", אולי שיבוש שיוצרת השפה. שוב, נראה שהדברים נקשרים שירות רבה למודל הפסיכולוגיה הקלינית, הטבוע בכל מי שעוסק בטיפול. הפסיכולוגיה הקלינית, לפחות זו המסורתית, מתהדרת בטיפול נפשי עמוק. בדיקה מילונית מעלה כי "עמוק" משמעו "בעל רבדים רבים, משמעותי, שורשי, יסודי, בסיסי, מהותי, עיקרי, רציני, חריף, עז, חזק, נוקב" (על פי מילון ספיר). צורת החשיבה שלנו, המושפעת מה, נוטה סביר שמי שפה מטפל טיפול עמוק – מטפל טיפול שטחי, שכן "שטחי" או "רדוד" הם היפוכם של ה"עמוק". כך מוגדרת באותה מילון המילה "שטחי": "לא מעמיק, רדוד, חד-מדי, דל, זול, חסר תוכן, מרפרף, פשטני, קל ערך, חסר דעת, נבער". האמנם ניתן לטעון נגד הפסיכולוגיה החינוכית שהיא מקצוע שטחי? נראה שהתשובה חד-משמעית "לא".

הפתרון לסתירה זו מצוי כנראה במילה רחב. על פי אותוון, "רחב" משמעו "מכיל פרטים ועניינים רבים, מקיף, מלא, עשיר, כולל הרבה מילים,". כל מי שמכיר מקרוב את הפסיכולוגיה החינוכית יסכים ודאי שהיא עונה לתחום עיסוק ברחבה. אם כך, "רחב" אינו "שטחי".

שחיינים אל מול צוללנים

דרך נוספת להתבונן על המתחם שבין ה"רחב" על ה"עמוק" היא באמצעות המטאפורה של שחיינים למול צוללנים: בעוד שהצוללן יורד לעומק המצולות, השחיין מרחקים. אין מי שיטען שהשחיין הוא היפוכו של הצוללן, או שהצללן מקצועי יותר (או פחות) מהשחיין. מדובר בשני מקצועות שונים זה מזה, הדורשים מהעוסקים בהם רמת מיומנויות שונה.

פסיכולוגים חינוכיים אמונים על רווחתם הנפשית של ילדים – מחייבת אותם לפתח מיומנויות "שחייה" – לקשר ולחבר בין אירועים ומצבים שונים; להפעיל את היעד שאלו שואפים להגיע (עם הילד, עם משפחתו); לפעול על פני השטח, קרוב למציאות, ולא רק במצולות הנפש.

סכנת הבינוניות והסכנות הנלוות לה

החשש מפני בינוניות חזר שוב בדיון הפסיכולוגים החינוכיים בפייסבוק. אין ספק בסכנה ממשית האור למקצוע בו תחומי אחריות וערוצי פעולה רבים ומגוונים כל כך. ובצד סכנת הבינוניות, כמעין תמונת ראי משלימה,מצאת סכנת ה"היבריס" או ה"גרנדיוזיות". באופן מעניין, נראה שאלה הם שני צדדים של אותו עניין: מי שמנסה להיות מומחה בתחומים רבים כל כך יכול להיחשד בגרנדיוזיות, ובהמשך של דבר - לבצע את משימותיו בבינוניות.

ואולם, בעיני קיימת "נוסחה" שעשויה "להציל" את הפסיכולוגים החינוכיים מפני סכנות אלה – סכנת הבינוניות מצד אחד, והגרנדיוזיות מהצד השני. הנוסחה שאני מציעה היא שילוב של צניעות מקצועית ושל מצוינות. צניעות מקצועית בראש ובראשונה ליושרה מקצועית ולהכרה בגבולות המקצוע ובגבולות הידע והכישורים של האנשים העוסקים בו. כל איש מקצוע רציני ואחראי חייב להיות מודע ליכולותיו ולכישוריו. כאשר המקרה המובא לפתחו מעורר בו שאלות וספקות, עליו להתייעץ – עם מדריכים, עם עמיתים למקצוע, או עם גורמים נוספים, כמו פקידת סעד. אחרים אחרים הפסיכולוג החינוכי יפנה את המקרה לאנשי מקצוע אחרים, או יעבוד איתם בשיתוף פעולה צמוד.

במילים אחרות, שחושבים שהפסיכולוג החינוכי "לשחות" היטב, אין משמעה שהוא אינו זקוק ל"צללים" סביבו – פסיכולוגים קליניים, התפתחותיים, שיקומיים וכדומה, פסיכיאטרים, נוירולוגים, מטפלים זוגיים, מטפלים מיניים, מעצבי התנהגות ועוד.

בצד הצניעות, יש לחתור ללא הרף למצוינות – לקבל הדרכה, לצאת להשתלמויות מקצועיות ולכנסים, לקרוא ספרות מקצועית, לשמור על סקרנות מקצועית, להתעדכן במחקר ובידע חדש, להתפתח אישי, לחתור לדעת עוד ועוד. אין ספק במקצוע קשה ותובעני, מקצוע שהלמידה בו אינה מסתיימת לעולם. בהקשר זה יש להבחין בין עקומת למידה מתמשכת בינונית: עקומת למידה מתמשכת משמעה שבמקצוע הפסיכולוגיה החינוכית זמן רב יותר להגיע לדרגת מקצועית גבוהה. שעומדות בפני הפסיכולוגים החינוכיים דרישות רבות כל כך, תחומים שונים כל כך, גורמת לכך שצריך לעבוד קשה כדי ללמוד – להכיר גישת טיפול נוספת, כלי אבחוני חדש, תחום ידע נוסף. זו גם אחת הסיבות לכך שקשה יותר לסיים התמחות בפסיכולוגיה חינוכית בתוך ארבע שנים. מצב זה אינו גורם את הפסיכולוגים החינוכיים לביניים. להיפך – הוא גורם לאנשי מקצוע שעובדים קשה ומתאמצים כדי להגיע לרמת מקצועיות גבוהה. זה ברור מאוד.

4. קידום בריאות נפשית

בבסיס הנושאים הנדונים כאן, כמו גם בבסיס הדיון הסוער בפייסבוק, מונחת ספציפית סוגיית מקצועיות. מבין השורות שואלים הפסיכולוגים החינוכיים את האנשים – עד כמה אנו מצליחים להיות מקצועיים. לא ניתן לענות על שאלה זו לשאול את השאלה הבסיסית – מקצועיים במה? או במילים אחרות – מהי מטרת המקצוע.

בחינה נוקבת של סוגייה זו נערכה במאמר שפורסם בשנת 2011 על ידי שניים מבכירי הפסיכולוגים הקליניים בארצות הברית: אלן קאזדין, שכיהן בעבר כנשיא איגוד הפסיכולוגים האמריקאים (APA), ושותפתו – הפסיכולוגית סטייסי בלייז (Kazdin & Blase, 2011). במאמר זה – מעורר טלטלה עזה בקרבת הקהילייה

הפסיכולוגית העולמית – קוראים קאזדין ובלייזר "לפרמט" מן היסוד (לאתחול מחדש) את עולם המחקר והטיפול הפסיכולוגי. לטענתם הפסיכולוגיה הקלאסית פושטת את הרגל, שכן היא לא מצליחה לממש את מטרתה המרכזית – להפחית את התחלואה הנפשית בכמות. קאזדין ובלייזר מספקים נתונים מטרידים, לפיהם על אף שהמחקר הפסיכולוגי מתקדם ומתפתח ושיטות שונות משתכללות – התחלואה הנפשית בעולם המערבי עולה בהתמדה. יתרה מכך: רק מעטים מבין הרווחים יצליחו לקבל טיפול פסיכולוגי – אפשר מוכרת, הידועה בשם "פר שירות" (Raviv, Sharvit, Raviv & Rosenblat-Stein, 2009; Stefl & Prosperi, 1985).

בהמשך המאמר מציעים קאזדין ובלייזר דרכי התערבות אלטרנטיביות שייתנו מענה למציאות החיים הבעייתית לעזרה ועזרה מצוות "פר שירות". בין היתר, הם מציעים הפצה של ידע פסיכולוגי באמצעות אנשי מקצוע אחרים – מורים, גננות, רופאים, אחיות; הם קוראים להשקעה רבה יותר במניה, ולא רק בטיפול; ולבסוף, טוענים קאזדין ובלייזה שהעבודה הפסיכולוגית צריכה להיע ברובה ב"סֶטינג" יומיומי (כדוגמת בתי ספר), שכן שם נמצאים אנשים שנפשיים – שם ולא בקליניקות. אף כי הדברים לא נכתבו באופן אישי מפורש, אפשר לרשום שקאזדין ובלייזר קוראים למעשה לפסיכולוגיה הקלינית לשאוב משיטות העבודה וצורת החשיבה של הפסיכולוגיה החינוכית. אפשר אף להבין את הצעתם כקוראת להגדלת נפח הפסיכולוגיה החינוכית, על חשבון הפסיכולוגיה הקלינית.

הקריאת "לפרמט" את עולם המחקר והטיפול הפסיכולוגי התקבלה בסערה בקרב הקהיל הפסיכולוגית; ואולם בעולמות הרפואה עוסקים בסוגיות מסוג זה כבר שנים רבות. ברפואה אין מי שחולק על חשיבות המגמה של הפנייתבים רבים יותר לרפואה מונעת ולאיתור מוקדם של מחלות. נסו לדמיין, למשל, את מערך הרפואה המודרנית חיס: ממתינים ללא מחלות קשות שיתפרצו כדייות – גם במקצועות. נסו לדמיין את מערך האה המודרנית ללא מודעות לרפואה מונעת , או *לגילוי מוקדם* של תרופות – שבוע שבו אין מודעות לנזקי עולמישון, לנזקי חשיפה לשמש, או לנזקיה של תזונה לקויה; עולם שבו אין מודעות לגילוי מחקר של סרטן – מערך רפואי שימושים יותר אונקולוגים מצויים, המחכים לסרטן שיתפרץ ויתפשט, ורק אז עושים מאמץ דרוש בו. מצב זה הוא אבסורדי כמובן.

במילים אחרות: ברור לגמרי שאחד טוב ממאפייניה מערכת רפואית ומתקדמת קשורה לנכונות להפנות משא רבים יותר לקידום בריאות, למניעת תחלואה, ולגילוי מוקדם של מחלות. בדומה לתחום הרפואה המונעת – ובהתאם לקריאת הכיוון שמציבים קאזדין ובלייז במאמרם – עיקר עיסוקים של פסיכולוגים חינוכיים קשור לקידום בריאות נפשית, למניעת פתולוגיה ולאיתור מוקדם של תחלואה נפשית. הפסיכולוגים החינוכיים אף פועלים באמצעות העברת הידע הפסיכולוגי וצורת החשיבה הפסיכולוגית לאנשי מקצוע אחרים – מנהלים, יועצות, מורים, גננות וכדומה.

אמנם לא תמיד ניתן להעריך את השפעתה המיטיבה של עבודת הפסיכולוג החינוכי. גם האחות שנותנת חיסון למאות תינוקות לא יודעת להעריך את חשיבות הפעולה, ולאמוד מה היה קורה לתינוק זה או אחר לולא קיבל את החיסון. עובדה זו אינה צריכה לרפות את ידי הפסיכולוגים החינוכיים, ואת ידיהם של יתר העוסקים בתהליכי מניעה.

פסיכולוגים חינוכיים עובדים במערכות חינוך המכילות מספר מאות, ולעתים אלפי תלמידים. עובדה זו מקנה לפסיכולוג החינוכי מוטת אקטיבית חשובה ביותר – הפקת מיטיבה שערכה לא יסולא בפז. בהנחה שמטרת הפסיכולוגיה היא קידום רווחה נפשית באוכלוסיה – יש לבחון את מקצועיות הפסיכולוגים החינוכיים בראש

ובראשונה לאור מטרה זו, ולהכיר בחשיבות הענקיות לקידום הרבה בריאות הנפש של ילדים, בני נוער ובני משפחותיהם.

5. גמישות

גמישות היא אחד ממאפייניו הבולטים של מקצוע הפסיכולוגיה החינוכית. הפסיכולוג החינוכי לדבר מגוון רחב של שפות מקצועיות, להטט בין מגוון רחב של משימות, ולהפעיל צורות חשיבה שונות (רודד, יצחקי וכהן, 2017). בנוסף, בשונה מה"משעה" הקבוע שבו נערך על פי רוב טיפול הפסיכולוגי הקליני – "מחשבה של זמן ומקום" – הפסיכולוגית הפסיכולוגית עוברת בין סביבות עבודה שונות, ובין מגוון רחב של לקוחות. על יום עבודה אחד עשוי הפסיכולוג החינוכי בין פגישה עם גננת המתקיימת בחצר המשחקים של הגן, פגישה טיפולית עם הורים המתקיים בתחנת שירות הפסיכולוגי-חינוכי, ומשם – מגוון רחב של פגישות בבית הספר: פגישה "אחד על אחד" בחדר המנהל, פגישה רבת משתתפים בחדר היועצת, פגישות בחדר המורים, ועוד. יצירתיות מיוחדות במיוחד (אך לא נדירים) עשויות הפסיכולוג החינוכי לפגוש הורים ב"דלת פתוחה" במתנ"ס השכונתי, לשמש כתובת מקצועית מרכז שבט הצופים, אפילו לעבוד עם אימהות טריות על הספסל בגינה פינת שמואל "טיפת חלב".

לגמישות בעבודת הפסיכולוג החינוכי יש יתרונות רבים. מעל לכול, מאפשרת לפסיכולוג החינוכי להגיע למספר רב ולמגוון רחב של לקוחות. במקביל, היא מעוררת עניין והנאה, ומגנה על הפסיכולוגים מפני שחיקה מקצועית (פראוי, 2013). עם זאת, צורת עבודה שכזו עלולה גם להקשות על הפסיכולוגים החינוכיים. כך קורה למשל כשפסיכולוג קובע פגישת עבודה עם מחנכת כיתה ו', היא מבקשת להתייעץ לגבי הבן הפרטי שלה. התלבטות אחרת מתעוררת כשהעצת בבית הספר מזמינה את הפסיכולוגית החינוכית לחגוג איתה את מסיבת בת-המצווה של בתה. לא קיימת כמובן נוסחה שתעזור לפסיכולוגים החינוכיים להחליט מתי מתאים להיענות להצעות סטייל זה, ומתי מוטב להציב להן גבול, ולשמור על זה בעמדה מקצועית נקייה יותר. חשוב להיות מודעים להתלבטות, ולשמור על מרחב בחירה והחלטה.

הפסיכולוג החינוכי כ"רופא משפחה"

ניתן היה לעסוק בטיפול הפסיכולוגי החינוכי יש ערך בכל הנוגע לעבודה מערכתית כשמגיעים לתחום – שם חשוב לשמור על "מחשבה" ברור, יציב וקבוע, שכן "מועד" שכזה נועד לשרת את צורכי המטופל. ואולם, גם טוענים זו אינה מדויקת. אמנם יש מטופלים (הורים, ילדים ובני נוער) ש"מגיעים" אכן קבוע חיוני עבורם ומשרת היטב את צורכיהם. חשוב לשמור עליו. ואולם אחרים אחרים, גם בטיפול – ובמיוחד בטיפולי הורים – יש ערך רב לגמישות.

"שעה להשכרה" ו"אסור להחסיר פגישות" הם מטבעות לשון מוכרים בעולם טיפול הפסיכולוגי. האמנם אסור להחסיר פגישות? ומה אם מצבו של המטופל? ללא שם: מדי שבוע, לאורך זמן? ומה אם קושי כלכלי מונע מבעדו לעשות זאת?

בשונה מהמודל לפיו "אסור להחסיר פגישות", פסיכולוגים חינוכיים רבים פועלים במודל הדומה לזה של רפואת משפחה. הם הופכים להיות כתובת מקצועית נגישה וזמינה שאליה ניתן לפנות כאשר מתעורר קושי. ממש כפי שרופא המשפחה לא יבקש להמשיך את הטיפול הפסיכולוגי יום, גם לאחר שדלקת הרפואה החלפה, כך גם המטופלים שלנו, או מוטב לומר – אנחנו צריכים להמשיך להגיע מדי שבוע, כאשר הם רואים שמהם סבלו חלפו או התמתנו. הרבה יותר, בטיפול קיים ערך לריווח רב יותר בין הפגישות טיפוליות. יצירת מרווחים בין

הפגישות, ומתן כבוד לתהליכים שהלקוחות שלנו עוברים בי/ הפגישות (ולא רק גישה לעצמן) - הם דרך מצוינת להפעיל את האנשים הטובים יותר. ומנגד, עם חלוף התוצאה, לא תמיד יש טעם לעשות סיום טיפול מוחלט ודרמטי. המציאות מוכיחה שבמקרים רבים צפים עם הזמן מעשיים חדשים, וחשוב להשאיר את הדלת פתוחה.

אם כך, גמישות בטיפול משמעה מתן כבוד רב ללקוח והעמדתו במרכז. הלקוח הוא זה שיודע טוב מכולם מה הם האנשים שלו. ובהקשר זה, כדאי לתת את הדעת לאחד הפרדוקסים הגדולים של עולם זה שבכלל זה במגזר פרטי, קבלת שירות כרוכה בתשלום. בדומה לרופא המייחל להחלמת המטופל, גם הפסיכולוג אמור לשאוף טיפול רפואי לא יזדקקו לו. במילים אחרות, מטרתו אמצעית של טיפול הפסיכולוגי היא שהטיפול יסתיים. להתנהל בצורה מיטיבה למול הפרדוקס הזה, הפסיכולוגית לרמה גבוהה של יושרה מקצועית. אלא אם הוא גדר במפורש אחרת, מצופה מה פסיכולוג לחתור בכל מאודו ועובדיו להשתפר.

---

6. יצירתיות ומרחב להתפתחות אישית

> החיים הם בעלי משמעות רק בתנאי שהיצירתיות היא חלק מחוויית החיים של היחיד. יצירת העולם היא החיים משהו לשמֵרוֹן הַחִיצָה לְחַטְיוֹת הַנִּקְוּת – לְבָרוֹא אֶת. כשאדם חי חיים יצירתיים הוא מגלה שכל מה שהוא עושה מחזק בו את הנפש שהוא חי ונאמן לעצמו...
> (ד.ו. ויניקוט, 1970, מתוך: חיים של יצירתיות)

מאפיינים הייחודיים של מקצוע הפסיכולוגיה החינוכית תורמים לאפשרות להתפתח בו לכיוונים שונים ויצירתיים. ואכן, פסיכולוגים חינוכיים רבים מתפתחים על שנות עבודתם לכיוונים שונים – מפתחים תחומי מומחיות ייחודיים; צוללים לתוך עולמות תוכן שונים (פגיעות מיניות, עובדות, התמכרויות, כישורים חברתיים); מתמחים באוכלוסיות ייחודיות (ילדים עם ASD, עבודה עם הורים, מחוננים, ילדים הביטוחיים מ-ADHD, נוער להט"בי, ועוד...); ומפתחים שיטות התערבות ייחודיות (כותבים ספרים להפצת הידע הפסיכולוגי, יוצרים משחקים, מפתחים תוכניות טיפול אינטרנטיות, מפעילים קבוצות טיפול ייחודיות, ועוד).

באופן מעניין, דווקא מיומנויות ה"שחייה" של הפסיכולוגים החינוכיים – רוחב היריעה, הראייה האינטגרטיבית, הגמישות – הן שמאפשרות לרבים מהם להפוך עם הזמן להיות (גם) "צוללנים". זה שילוב מופלא ביותר, המקנה לפסיכולוגים החינוכיים יתרון משמעותי בכל הנוגע לעבודה עם הורים וילדים. היצירתיות תורמת לגיוון, מסייעת למניעת שחיקה במקצוע, והופכת את הפסיכולוגים החינוכיים לאנשי מקצוע שכדאי ונכון להפנות אליהם.

7. "גאות יחידה" ויוקרה מקצועית

פתחתי את המאמר באמירה שהדיון הסוער בפייסבוק כנראה לא יכול היה להתנהל לפני עשר שנים. וכאן המקום להסביר. נדיר להיות עדים (ואף שותפים פעילים) לתהליכי שינוי משמעותיים חוללים ביחס למעמדה של המקצוע, ולהבחין בזמן אמת, תוך כדי התרחשותם. הפסיכולוגיה החינוכית עוברת בעשר השנים האחרונות תהליכים שינויים משמעותיים שכאלה – תהליכי שינוי שכל מי שעוסק במקצוע לאורך זמן חש בהם, ועשוי אף להיות שותף פעיל בהם, ולעזור לחולל את השינוי.

עד לפני שנים רבות, הפסיכולוגיה החינוכית הייתה מספקת "בארון". פסיכולוגים חינוכיים רבים בחרו להציג את האנשים כ-"פסיכולוגים" (מבלי לציין את תחום מומחיותם), או כ"בוגרי המגמה הקלינית", ולוותר על המקצוע המלא – "חינוכי מומחה". בציבור הרחב רווחה התפיסה כי רק פסיכולוגיה קלינית היא פסיכולוגית

רצינית; הם יכולים "נחשבים", או נחשבים פחות. הרבה פחות. משמח לגלות שמגמה זו מדרג מאוד מבוקש.

על מנת להבין איך מתחוללים תהליכי שינוי אלה, ניעזר במושגים מחקר של הפסיכולוגיה החברתית, המבקשים לבחון מה הם הגורמים התורמים לפיתוח "גאותה". איך, למשל, נוצרה תחושת גאווה אצל אוהד קבוצת כדורגל, או אצל חייל בצנחנים. נראה ש"גאוות יחידה" מתפתחת שילוב של גורמים פנימיים בתוך היחידים, וגורמים חיצוניים קשורים ליחס שבין הקבוצה אליה האדם משתייך לקבוצות אחרות (Balliet, Wu & De Dreu, 2014).

הגורמים התורמים לפיתוח "גאות יחידה" בקרב פסיכולוגים חינוכיים

בהתייחס לגורמים הפנימיים, "גאות יחידה" היא מעל לכול נפש פנימית של האדם. היא נוצרה על בסיס רצונו של כל אדם, כך שלא ניתן להראות לאנשים "להתלהב", "להתרגש" או "להרגיש גאווה". היא מתקיימת אצל קבוצה של יחידים, יש בה עוצמה מדבקת, המתחילה כשהיא לחולל את עצמה. בין הגורמים התורמים לתחום הפנימי של "גאות יחידה" ניתן למנות את תחושת השייכות של האדם לארגון לתחום העיסוק; תחושת המשמעות של האדם, הנלווית לעיסוק בעיסוק; הכרת האדם בחשיבות העיסוק, והכרת האדם במקצועיות התחום שבו הוא עוסק. לאור הדברים שנכתבו, נראה שלפסיכולוגים החינוכיים יש בהחלט סיבות טובות לחוש גאווה.

ומה באשר לגורמים החיצוניים התורמים לפיתוח "גאות יחידה"? אלה ייצור את רמת ה"ייחודיות החיובית" של הקבוצה: טיפת החדירות שלה – כלומר המידה שבה היא סלקטיבית בקבלת חברים חדשים; הייט הניידות החברתית – כלומר המידה חברי הקבוצה נוטים לעזוב ולעבור לקבוצות אחרות; היררכיית הסטטוס הבין-קבוצתי; וכן הלגיטימיות מקצועית של הקבוצה.

בתחום זה מתחולל שינוי משמעותי בעשר השנים האחרונות. נקודת ציון מרכזית חלה בדצמבר 2010, עם חקיקת הכנסת את התיקון לסעיף 9 ב' בחוק הפסיכותרפיה. המקורי, שנחקק בשנת 1977, קבע כי רק פסיכולוגים קליניים מורשים לעסוק בטיפול. ואולם, מאז נחקק החוק התפתחו בארץ תחומי מומחיות רבים נוספים בפסיכולוגיה: פסיכולוגיה חינוכית, התפתחותית, שיקומית ורפואית. התיקון לסעיף 9 ב' חולל את השינוי המתבקש, וקבע כי כל פסיכולוג מומחה יכול לעסוק בטיפול בתחום מומחיותו. התיקון לחוק תרם תרומה חוק ללגיטימיות מקצועית של הפסיכולוגיה החינוכית, להכרה בייחודיותה, ולהיררכיית הסטטוס הבין-קבוצתי של המקצוע.

נדבך מרכזי נוסף ביצירת "גאוות יחידה" בפסיכולוגיה חינוכית קשורה לאקדמיזציה של התחום. המועמדים נפתחו במכללות שונות ברחבי הארץ מספר תוכניות לימוד מצוינות לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית. בעבר היו לומדים את עבודת עקרונות "תוך כדי תנועה", הרי שכיום מסלולי לימודים סדורים ומקים מכשירים את הפסיכולוגים החינוכיים לתפקידם, ברמה אקדמית וברמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך שילוב של התנסות מעשית בשטח ("פרקטיקום").

מצב זה הוא לאפשר לחנות שירות הפסיכולוגי-חינוכי להעלות את דרישות הקבלה להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית. בעבר הלא-רחוק הייתה ההתמחות החינוכית פתוחה בפני כל מי שסיים תואר שני בפסיכולוגיה. החל משנת 2015 הוצבו על ידי משרד הבריאות דרישות חדשות, לפיהן רק מי שסיים לימודים במגמה חינוכית או במגמה קלינית של הילד, יכול להתקבל להתמחות חינוכית. כל הדרוש ללמוד בתוכנית השלמה דו-שנתית, תומך פרקטיקום חינוכי, ורק אז צריך להגיש בקשת קבלה להתמחות חינוכית. מצב זה תורם אף הוא לעלייה במקצועיות התחום ובהיררכיות הסטטוס הבין-מקצועי שלו.

שילוב כל הגורמים יחד – הגורמים הפנימיים והגורמים החיצוניים – תורם את תחושת הזהות המקצועית להגבר ולחיזוק "גאות היחידה" של המקצוע. מעניין שאפשר לראות במגוון הרחב של המאמר המקצועי שכתבו לאחורנה ביטוי למקצוע הפסיכולוגיה החינות (ברכוז, 2017; דור-חיים, 2017; עיני, 2017; רודד ואחרים, 2017). לכל שילוב אלה, הדיון הסוער והמרתק שהתנהל בקבוצת הפייסבוק של הפסיכולוגים החינוכיים משקף את הלכי הרוח של הפסיכולוגים החינוכיים בשטח, ומחזק את הנפש שמקצוע הפסיכולוגיה החינוכית אכן נמצא במקום אחר.

סיכום

במאמר זה ביקשתי להתחקות אחר מאפיינים של מקצוע הפסיכולוגיה החינוכית, כפי שאני תופסת אותו. הוא נכתב מתוך זווית ראייה של מי שעוסקת במקצוע, "נושמת" אותו, מזוהה איתו, מלמדת אותו, ושותפה להכשרת "הדור הבא" של הפסיכולוגים החינוכיים. לא ניסיתי להסתיר את אהבתי הרבה למקצוע ואמונתי העמוקה בחשיבותו.

לתפיסתי, הפסיכולוגים החינוכיים הם בראש ובראשונה "שחיינים" – אנשי מקצוע המצוידים בראייה רחבה ואינטגרטיבית של כל מקרה הבא לפתחם. צורת ראייה זו רלוונטית מאוד וחשובה כשמדובר בקידום רווחה נפשית בכלל, ובקידום רווחתם הנפשית של ילדים ובני נוער, בפרט. בנוסף, פסיכולוגים חינוכיים ממוקמים במעמדת מפתח ייחודיות, ומצוידים במיומנות חשובה מאין כמוה, המאפשרת להם "לנהל את המקרה" , או "לנצח על התזמורת".

זאת ועוד – פסיכולוגים חינוכיים מפתחים על הכרם ועבודתם את החשבון המערכתי, לתפוס את המורכבות מערכת המונה, ולעזור למערכות החינוך השונות לקדם את הרווחתם הנפשית של הסברה הנפשית. הם מפתחים מקצועיים ומיומנויות במגוון רחב של תחומי תוכן וערוצי פעולה. מוטת ההשפעה הרחבה שלהן והעסקת הנרחב בתהליכי מניעה הופכים את הפסיכולוגים החינוכיים לכאלה שמסייעים לקידום בריאות ורווחה נפשית באוכולסייה. בנוסף, זהו מקצוע המתאפיין במישות, על כל היבטיה, ולפיכך מאפשר לעוסקים בו יצירתיות ומרחב עצום להתפתחות מקצועית ולהתמקחות, כך שרבים מהפסיכולוגים החינוכיים הופכים עם הזמן להיות גם "צללים".

שילוב הגורמים הרבים שנסקרו, ועוד גורמים רבים אחרים בציצים בשטח מידי יום ביומו, גורם לפסיכולוגיה החינוכית לפרוח כתחום מומחיות מרתק, חשוב מאין כמותו ובעל רחבה רחבה (ועמוקה) על עולם פסיכולוגי ופסיכולוגיה כללית.

תודות

ברצוני להודות לד"ר אלונה רודד, על היוזמה והעידוד לפיתוח ההרצאה שעליה מבוסס המאמר; תודה לשחר בילר, מנהלת קבוצת הפייסבוק של הפסיכולוגים החינוכיים; תודה לאפרת אבן-צור על העריכה מקצועית והרגישה.

מקורות

ארנריך, י' (2018). תאוריה ייעודית לעבודה מערכתית בבית הספר: אתגרים ומחשבות על חזון אפשרי (גרסה אלקטרונית). נדלה ב- 7/2/2018, מאתר פסיכולוגיה עברית: https://www.hebpsy.net/....asp?id=3644

בחור-ניר, ד' (2007). "הכירים". גולבס, 31.10.2007, (גרסה אלקטרונית). נדלה ב- 7/2/2018, מאתר "גלובס": http://www.globes.co.il...d=1000269695

ברכוז, א' (2017). תפקיד הפסיכולוג החינוכי בטיפול בילדים עם הפרעת קשב וריכוז, פסיכואקטואליה, 31-37.

גרופמן, ג'. (2009). חושבים: איך הם. הוצ' מטר.

דור-חיים, פ' (2017). התערבות פסיכולוגית אינטגרטיבית במערכות חינוך. [גרסה אלקטרונית]. נדלה ב- 7/2/2018, מאתר פסיכולוגיה עברית: http://www.hebpsy.net/a....asp?id=3548

ויניקוט, ד"ו (1970). חיים של יצירתיות. בתוך: ד.ו. ויניקוט (1995) הכול מתחיל בבית. תל אביב: דביר.

כהן, א' (2017). טיפול בהורות. קרית ביאליק: אח, עמ' 117-47.

עיני, נ' (יולי 2017). פסיכולוגיה חינוכית חוצת גבולות. פסיכואקטואליה, 21-11.

פראוי, ת' (2013). מה זה אומר להיות פסיכולוג חינוכי? משמעות המושג והחוויה בעיני העוסקים במלאכה (גרסה אלקטרונית). נדלה ב- 7/2/2018, מאתר פסיכולוגיה עברית: https://www.hebpsy.net/....asp?id=2984

רודד, א' , יצחקי, נ' , כהן, מ' (2017). להניע את הקֶלֵידוֹסְקוֹפ: ליבת המקצוע והיחוד המקצועי של הפסיכולוגיה החינוכית (גרסה אלקטרונית). נדלה ב 7/2/2018, מאתר פסיכולוגיה עברית: https://www.hebpsy.net/....asp?id=3618

Balliet, D., Wu, J., & De Dreu, C.,KW (2014). העדפה בין קבוצות בשיתוף פעולה: מטה-אנליזה. עלון פסיכולוגי-, 140(6), 1556.

Kazdin, AE, & Blase, SL (2011). הפעלה מחדש של מחקר ותרגול פסיכותרפיה להפחתת הנטל של מחלות נפש. Perspectives on Psychological Science, 6(1), 21-37.

Raviv, A., Sharvit, K., Raviv, A., & Rosenblat-Stein, S. (2009). חוסר הרצון של אמהות ואבות לפנות לעזרה פסיכולוגית עבור ילדיהם. כתב עת ללימודי ילד ומשפחה, 18 (2), 151-162.

Stefl, ME, & Prosperi, DC (1985). חסמים לניצול שירותי בריאות הנפש. כתב עת קהילתי לבריאות הנפש, 21, 167-178.

Winnicott, DW (1960). התיאוריה של יחסי הורה-תינוק. כתב העת הבינלאומי של פסיכו-אנליזה. 41, 585-595.

לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.